缬沙坦

知识类别：药品说明书
资料来源：中国医药信息查询平台（经审核认证词条，逐字转载）
来源 URL：https://www.dayi.org.cn/drug/1151975.html
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

缬沙坦
缬沙坦，西药名。常用剂型为片剂、胶囊剂。为降血压药。用于各种轻至中度高血压，尤其适用于对ACE抑制剂不耐受的患者。
英文名称
汉语拼音
药品类型
处方类型
医保类型
参考价格
成分
性状
适应症
规格
用法用量
临床应用及指南
不良反应
禁忌
注意事项
药物相互作用
药理作用
药代动力学
贮藏方法
有效期
执行标准
成分
本品主要成份为缬沙坦。
性状
缬沙坦胶囊：内容物为白色或类白色颗粒或粉末。
缬沙坦分散片：白色片。
适应症
本品用于各种轻至中度高血压，尤其适用于对ACE抑制剂不耐受的患者。
规格
缬沙坦胶囊：40mg；80mg；160mg。
缬沙坦分散片：80mg。
用法用量

本品不同剂型、不同规格的用法用量可能存在差异，请阅读具体药物说明书使用，或遵医嘱。
1、推荐剂量为80mg，每日一次，与性别、年龄及种族无关。可以在进餐时或空腹时服用。建议每天在同一时间用药（如早晨）。
2、2周内出现抗高血压作用，4周后作用达最大。未能充分控制血压的患者，日剂量可增至160mg或加用利尿剂。本药可与其他抗高血压制剂合用。
3、对轻到中度肾功能损伤患者或非胆管性及非胆汁瘀积型肝功能不全患者无需调整剂量。
4、老年患者无需调整剂量。
5、尚无用于儿童患者的安全性和有效性资料。
6、高血压患者服用本药，在血压下降同时不影响心率。
7、突然停用本药时，不会出现血压反跳和其它临床不良反应。
8、多剂量服用本药对总胆固醇、空腹甘油三酯、空腹血糖和尿酸无明显影响。
临床应用及指南
1、李艳艳，童林萍，吴福斌等通过缬沙坦联合卡托普利治疗糖尿病肾病合并高血压的疗效观察，得出结论缬沙坦联合卡托普利治疗糖尿病肾病合并高血压效果优于单一用药,且较为安全。（心脑血管病防治,2019,19(05):464-466.）
2、张先维通过缬沙坦联合美托洛尔治疗高血压并冠心病的临床分析，得出结论缬沙坦联合美托洛尔口服治疗,能显著降低高血压合并冠心病患者的收缩压和舒张压,有效控制患者血压,临床疗效显著,对病人心绞痛症状改善明显。（江西医药,2019,54(10):1211-1213.）
3、高雪丽通过缬沙坦联合美托洛尔对高血压病并快速性心律失常的影响价值分析，得出结论美托洛尔联合缬沙坦在治疗高血压病并快速心率失常方面有很好的治疗效果,值得临床借鉴。（中西医结合心血管病电子杂志,2019,7(28):68+71.）
4、李爱丽通过缬沙坦联合氨氯地平治疗社区老年原发高血压合并糖尿病疗效，得出结论对于社区老年原发高血压合并糖尿病患者,缬沙坦联合氨氯地平的疗效明显比单药疗效更佳,可明显控制血糖以及血压水平,改善肾功能,减少不良反应发生率,促进患者健康。（中国社区医师,2019,35(28):65+67.）
不良反应
1、包括2316名患者的安慰剂对照试验，全面比较了本品和安慰剂的副作用。以下列出10个安慰剂对照试验报告的不良反应发生情况，患者服用缬沙坦10-320mg/日，直至12周。2316名患者中1281人、660人、分别服用80mg、160mg。不良反应发生率与用药剂量及用药时间无关，因此，将各种剂量下发生的不良反应合并统计。不良反应的发生率与性别、年龄、种族无关。所有发生率≥1%的不良反应如下（无论是否与所研究的药物有关）：头痛、头晕、病毒感染、上呼吸道感染、咳嗽、腹泻、疲乏、鼻炎、鼻窦炎、背痛、腹痛、恶心、咽炎、关节痛。
2、其它发生率低于1%的不良反应有：水肿、无力、失眠、皮疹、性欲降低。这些不良反应是否与缬沙坦治疗有因果关系尚不知晓。
3、产品投入市场后，曾出现一些罕见的报道，包括：血管神经性水肿、皮疹、瘙痒及其它超敏反应如血清病、血管炎等过敏性反应。
4、试验室研究结果：
（1）罕见情况下，缬沙坦引起血红蛋白和血球压积降低。临床对照试验发现，缬沙坦治疗组血红蛋白和血球压积明显降低（＞20%）的分别为0.8%和0.4%。安慰剂组为0.1%。
（2）临床对照试验发现中性粒细胞减少见于1.9%缬沙坦治疗患者、1.6%ACEI治疗患者。缬沙坦组血清肌酐、血钾、总胆红素显著升高者分别为0.8%、4.4%、6%，ACEI组分别为1.6%、6.4%、12.9%。偶见肝功能指标升高。原发性高血压患者接受缬沙坦治疗时，不需要监测特殊试验室指标。
禁忌
1、已知对本品过敏者禁用。
2、妊娠和哺乳期妇女禁用。

3、对严重肾功能衰竭（肌酐清除率＜10ml/min）患者尚无应用本品的经验。

注意事项

1、低钠和/或血容量不足：极少数情况下，严重缺钠和/或血容量不足患者（如大剂量应用利尿剂），应用本品治疗开始时，可能出现症状性低血压。应该在用药之前，纠正低钠和/或血容量不足，或将利尿剂减量。如果发生低血压，应该让患者平卧，必要时静脉输注生理盐水。血压稳定后恢复本品治疗。

2、肾动脉狭窄：12例因单侧肾动脉狭窄导致的继发性肾血管性高血压患者服用本品4天，没有引起肾血流动力学、肌酐、尿素氮（BUN）明显变化。由于其它作用于RAAS的药物可能使单侧或双侧肾动脉狭窄患者的BUN和肌酐升高，建议进行监测确保安全。

3、肾功能不全：肾功能不全患者不需要调整剂量。

4、肝功能不全：肝功能不全患者不需要调整剂量。轻至中度肝功能不全患者缬沙坦剂量不应超过80mg/日。

5、缬沙坦主要以原型从胆汁排泄，胆道梗阻患者排泄减少（见【药代动力学】），对这类患者使用缬沙坦应特别小心。

6、与其它抗高血压药一样，服药患者在驾驶、操纵机器时应小心。

7、孕妇及哺乳期妇女用药：

（1）早期（妊娠头3个月）：妊娠种类B。动物实验表明对胎儿没有危害。

（2）中期和晚期（妊娠第2、第3个3个月）：妊娠种类D。有证据表明对人类胎儿有危害，但相对母亲获得的治疗益处而言，利大于弊。鉴于血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂的作用机制，不能排除对胎儿的危害。

（3）妊娠中、晚期应用直接作用于RAAS的药物，可以导致胎儿的伤害或死亡。胎儿从妊娠中期开始出现肾灌注，后者依赖于RAAS系统的发育，因此妊娠中晚期应用本品，风险增高。

（4）与其他直接作用于RAAS的药物相似，本品不宜用于妊娠期。如果在用药期间发现妊娠，应尽早停用缬沙坦。

（5）所有在宫内与药物接触过的新生儿应密切观察，保证足够的尿量、防止高血钾、监测血压。必要时采用适当治疗措施（如再水化），清除药物。

（6）缬沙坦可以从兔的乳汁排出，目前尚无对哺乳期女性的研究，因此本品不宜用于哺乳期。

8、儿童用药：本品用于儿童的有效性和安全性尚无相关研究。尚无儿童用药的经验。

9、老年用药：尽管服用缬沙坦后，老年人的系统暴露浓度稍大于年轻人，但并无任何临床意义。

10、药物过量：虽然尚无本品过量的诊治经验，但其主要症状可能是明显低血压。若服药时间不长，应该催吐治疗，否则常规治疗给予生理盐水静脉输注。血液透析不能清除缬沙坦。

药物相互作用

1、临床没有发现明显的药物相互作用。已对以下药物进行了研究：西米替丁、华法令、呋噻米、地高辛、阿替洛尔、吲哚美辛、氢氯噻嗪、氨氯地平和格列本脲。

2、由于缬沙坦几乎不经过代谢，临床没有发现与诱导或抑制细胞色素P450系统的药物发生相互影响。

3、虽然缬沙坦大部分与血浆蛋白结合，但是体外实验没有发现它在这一水平与其他血浆蛋白结合药物（如双氯芬酸、呋噻米、华法令）发生相互作用。

4、与保钾利尿剂（如螺内脂、氨苯蝶啶、阿米洛利）联合应用时，补钾或使用含钾制剂可导致血钾浓度升高。因此，联合用药时需要注意。

药理作用

1、作用机制：

（1）肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RAAS）的激活剂是血管紧张素Ⅱ，是由血管紧张素Ⅰ在血管紧张素转化酶（ACE）作用下形成的。血管紧张素Ⅱ与各种组织细胞膜上的特异受体结合。它有多种生理效应，包括直接或间接参与血压调节。血管紧张素Ⅱ是一种强力缩血管物质，具有直接的升压效应，同

时还可促进钠的重吸收，刺激醛固酮分泌。
（2）缬沙坦是一种口服有效的特异性血管紧张素（AT）II受体拮抗剂，它选择性作用于AT 1 受体亚型，产生所有已知的效应。AT 2 受体亚型与心血管效应无关。缬沙坦对AT 1 受体没有任何部分激动剂的活性。缬沙坦与AT 1 受体的亲和力比AT 2 受体强20000倍。
（3）ACE将血管紧张素Ⅰ转化成血管紧张素II，并降解缓激肽。血管紧张素II受体拮抗剂-缬沙坦对ACE没有抑制作用，不引起缓激肽或P物质的潴留，所以不会引起咳嗽。比较缬沙坦与ACE抑制剂的临床试验证实缬沙坦组干咳的发生率（2.6%）显著低于ACE抑制剂组（7.9%）（p＜0.05）。在一项对曾接受ACE抑制剂治疗后发生干咳症状的患者进行的临床试验发现，缬沙坦组、利尿剂组、ACEI组分别有19.5%、19.0%、68.5%患者出现咳嗽（p＜0.05）。缬沙坦对其它已知的在心血管调节中起重要作用的激素受体或离子通道无影响。
2、药效：
（1）缬沙坦降低升高的血压，同时不影响心率。
（2）对大多数患者，单剂口服2小时内产生降压效果，4-6小时达作用高峰，降压效果维持至服药后24小时以上。治疗2-4周后达最大降压疗效，并在长期治疗期间保持疗效。与噻嗪类利尿剂合用可进一步显著增强降压效果。
（3）突然中止缬沙坦治疗，不引起高血压“反跳”或其它副作用。
（4）缬沙坦不影响高血压患者的总胆固醇、甘油三酯、血糖和尿酸水平。
药代动力学
1、吸收：
（1）缬沙坦口服后吸收迅速，其吸收量差异很大，平均绝对生物利用度为23%（23±7），在研究的剂量范围内，药代动力学曲线呈线性。每天服用一次时，缬沙坦很少引起蓄积，在男性和女性中，血浆浓度相似。
（2）进餐时服用缬沙坦，使AUC减少48%，血药浓度峰值（C max ）减少59%。无论是否进餐时服用，8小时后的血药浓度相似。AUC或C max 减少对临床疗效无明显影响，本品可以进餐时或空腹服用。
2、分布：
缬沙坦绝大部分（94-97%）与血清蛋白（主要是白蛋白）结合，1周内达稳态。稳态分布容积约为17L，与肝血流量（30L/h）相比，血浆清除速度相对较慢（大约2L/h）。
3、清除：
（1）缬沙坦以多指数衰变动力学代谢（α相半衰期＜1小时，终末半衰期约9小时）。
（2）缬沙坦主要以原形排泄，70%从粪便排出，30%从尿排出。
4、特殊临床情况下的药代动力学：
（1）老年人：与青年志愿者相比，一些老年人（＞65岁）缬沙坦全身组织浓度稍增高，但无临床意义。
（2）肾功能不全患者：由于缬沙坦仅有30%从肾排泄，肾功能与缬沙坦组织浓度间无明确相关性。因此，肾功能不全患者不必调整剂量。尚未见关于透析患者的研究，但鉴于缬沙坦与血清蛋白高度结合，不大可能经透析清除。
（3）肝功能不全者：大约70%的缬沙坦以原形经胆汁排泄，缬沙坦不经生物转化，因此，缬沙坦全身组织浓度与肝功能不全无关。对非胆管源性、无淤胆的肝功能不全患者，不必调整剂量。胆汁性肝硬变或胆道梗阻患者，缬沙坦的AUC增加约1倍。
贮藏方法
遮光，密封，在30℃以下保存。
有效期
执行标准
缬沙坦胶囊：中国药典2015年版二部。

缬沙坦分散片：国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-（X-003）-2009Z。